

**Université Constantine 3
Faculté de Médecine
Service de Médecine Interne
CHU Dr Benbadis Constantine**

Pr H.Benabderrahmane

Sémiologie de la glande thyroïde

Plan du cours:

- 1 Rappel anatomophysiologique**
- 2 Examen clinique de la glande thyroïde**
 - A- Technique de l'examen :**
 - Examen face antérieure du cou
 - Examen régional
 - B- Résultats de l'examen :**
 - A l'état normal
 - En pathologie
- 3- Anomalies fonctionnelles de la thyroïde**
 - A- Hyperthyroïdie**
 - B- Hypothyroïdie**

**Selon le programme national d'enseignement 3eme année Médecine
Année Universitaire 2025-2026**

1-Rappel anatomo-physiologique:

► Rappel anatomique :

Le corps thyroïde-dont le poids ne dépasse pas 30 g-est situé à la partie antérieure et basse du cou ou il enserme en «fer à cheval» les faces latérales du larynx et les premiers anneaux de la trachée.

Classiquement comparée à un papillon à cause de sa forme, la glande thyroïde comprend 3 éléments : les 2 lobes latéraux et un isthme.

Par la face postérieure de ses lobes latéraux le corps thyroïde contracte 2 rapports étroits et de grande importance en pathologie :

- d'une part les parathyroïdes
- d'autre part les nerfs récurrents

La glande thyroïde est solidaire de l'axe aéro-digestif ce qui explique sa mobilité aux mouvements de déglutition : constatation de grande valeur sémiologique en pathologie thyroïdienne. (Figure a)

► Rappel physiologique :

Le corps thyroïde sécrète les hormones thyroïdiennes :triiodothyronine (T3) et thyroxine (T4)

Cette sécrétion est réglée par une stimuline hypophysaire : TSH (feed back négatif).TSH elle-même sous le contrôle de la TRH hypothalamique.

Les actions physiologiques de ces hormones sont :

- action sur la morphogenèse et la croissance : elles accélèrent la croissance et favorisent à forte dose la soudure des cartilages de conjugaison, elles favorisent également la maturation du système nerveux et le métabolisme du muscle et du collagène
- action sur la thermorégulation et le métabolisme de base.
- actions sur cœur, tube digestif, muscle, système nerveux : un certain nombre d'actions semble s'exercer par l'intermédiaire du système nerveux sympathique en favorisant l'action des catécholamines : tachycardie, accélération du transit intestinal, accélération du réflexe achilléen et de la conduction nerveuse.

-action sur les métabolismes :

- hyperglycémie (action sur la glycogénolyse hépatique)
- catabolisme accéléré des graisses
- effet protidique semblant anabolique à faible dose et catabolique à doses plus fortes surtout sur l'os et le muscle
- Effet diurétique

2-Examen clinique du corps thyroïde

A-Technique de l'examen :

●**examen de la face antérieure du cou** : recherche de la glande thyroïde : seule glande accessible à l'inspection et à la palpation.

■**Inspection** : temps important

-**Technique** : patient confortablement assis, tête légèrement inclinée en avant de façon à ne pas tendre les muscles pré-hyoïdiens (ce qui repousserait la glande en profondeur)

-**Renseignements fournis** :

- modifications du volume du cou : la présence d'un goitre est souvent détectée de cette façon
- modifications cutanées : pigmentation (erythème)
- modifications vasculaires : éréthisme des vaisseaux du cou, bouffées vasomotrices.

■**Palpation** : temps capital de l'examen

-**Technique** : patient placé dans la position déjà décrite.

Il existe 2 techniques :

→**examineur derrière le malade** : enserrant doucement de ses doigts la région sous-hyoïdienne : le palper s'effectue de haut en bas et latéralement en demandant au patient de déglutir(Figure2)

→ **examineur face au malade** : et en insinuant 1 ou plusieurs doigts entre le larynx et le muscle sterno-cléido-mastoïdien (droit puis gauche) refoule latéralement la glande ce qui permet d'amener en avant le lobe correspondant.(Figure1)

-Résultats : La palpation permet de :

- préciser les modifications de volume : mesurer le tour de cou (ruban mètre)
- noter la topographie d'une hypertrophie : diffuse (2 lobes avec isthme) ou localisée (un lobe ou une partie de lobe)
- apprécier l'homogénéité : zones hyperplasiques, nodules, ou association des deux éléments
- préciser 3 points :
 - consistance : ferme, dure, molle, rénitente
 - sensibilité ou non
 - mobilité par rapport à la peau et aux muscles
- enfin la palpation peut percevoir un thrill : c'est un frémissement particulier systolique ou à renforcement systolique qui traduit un souffle vasculaire.

■Auscultation :

- Recherche essentiellement l'existence d'un souffle qui traduirait l'hypervascularisation du goitre
- Ne pas confondre avec le souffle respiratoire (demander au patient de ne pas respirer quelques secondes)
- Ne pas confondre aussi avec un souffle du paquet vasculaire carotidien

●Examen régional : comporte 3 points importants :

- **la recherche d'adénopathies** : il faut palper :

Les chaînes lymphatiques antérieure et latérale, le creux sus claviculaire, les chaînes trapeziennes et spinales

-**la recherche des limites thyroïdiennes** :

Vers le bas : il est souvent difficile d'examiner un lobe thyroïdien pourtant ceci est essentiel car il existe des goitres plongeants à prolongement médiastinal et des goitres endothoraciques

Vers le haut : la clinique est plus facile.

-**la recherche de signes de compression** :

- respiratoire (trachée) : wheezing, dyspnée, cyanose
- digestive (œsophage) : dysphagie, douleur et angoisse à la déglutition
- nerveuse (nerfs récurrents) : voix bitonale

B- Résultats de l'examen :

● A l'état normal :

La thyroïde n'est habituellement pas palpable.

Dans certains cas pourtant elle est palpable :

- enfant en croissance
- jeune fille à la puberté
- jeune femme en période prémenstruelle
- au cours de la grossesse

La thyroïde est alors régulièrement augmentée de volume, homogène, élastique, indolente, non vasculaire

● En pathologie :

L'augmentation du volume du corps thyroïde est appelée goitre :

➤ On distingue de façon purement descriptive :

- goitres diffus : respectant la silhouette d'ensemble du corps thyroïde
- goitres nodulaires ou nodules thyroïdiens (nodule isolé ou goitre plurinodulaire)

➤ en 1974, L'OMS, a proposé la classification clinique suivante :

Stade 0-A : pas de goitre

Stade 0-B : goitre uniquement palpable, non visible le cou en hyperextension

Stade I : goitre palpable et visible seulement en hyperextension

Stade II : goitre visible le cou en position normale

Stade III : très gros goitre visible à distance.

Cette classification est approximative ; Elle a surtout un intérêt dans les enquêtes épidémiologiques.

➤ Les caractéristiques sémiologiques de malignité d'un goitre sont : nodule dur, irrégulier, fixé ou peu mobile avec les tissus sous-jacents avec la présence possible d'adénopathies cervicales

3 – Anomalies fonctionnelles de la thyroïde

A –Hyperthyroïdie

En exemple, nous décrivons une étiologie d'hyperthyroïdie d'origine auto-immune : la maladie de Basedow.

La forme typique est caractérisée par :

► **5 signes majeurs** : goitre, exophtalmie, tachycardie, tremblement et amaigrissement.

1-Goitre : il est diffus, homogène, mobile avec les mouvements de la déglutition, vasculaire (caractère essentiel) donc expansif à la palpation et soufflant à l'auscultation : le souffle est systolique ou à prédominance systolique et assez fort pour percevoir un thrill à la palpation .Ce goitre est isolé sans signes de compression ni d'adénopathies. (Figure3)

2-Signes oculaires : ils précèdent parfois l'hyperthyroïdie, uni ou bilatéraux, avec éclat du regard, et sont présents dans 60% des cas. Ils sont classés sous 2 rubriques :

●**signes palpébro-rétractiles** :

-signe de **DALRYMPLE** : rétraction palpébro –supérieure et apparition du limbe sus cornéen.

-signe de **de GRAEFE** : asynergie oculo-palpébrale dans le regard vers le bas avec augmentation du limbe sus cornéen

-signe de **GIFFORD** : approfondissement du pli marquant l'insertion du muscle releveur les yeux fermés

-rareté du clignement.

●**exophtalmie** :

Elle est particulièrement frappante : c'est la protrusion bilatérale et symétrique des globes oculaires .elle donne au regard un aspect fixe, brillant,tragique, caractéristique.(Figure3)

A l'examen on retrouve :

- une éversion de la paupière inférieure : signe de **POCHIN**
- parfois un défaut de convergence : signe de **MOEBIUS**

3- Tachycardie :

signe constant et indispensable au diagnostic : c'est une tachycardie sinusale rapide (110-120 batts /mn) permanente et régulière.

Elle persiste au repos et s'exagère aux émotions.

4- Tremblement : il doit être recherché :

- aux membres supérieurs : par l'attitude du serment
 - aux membres inférieurs : en appuyant la pointe du pied au sol
- Il est fin, menu, rapide, permanent et involontaire donc s'exagère aux émotions et s'atténue au repos.

5-Amaigrissement : symptôme essentiel : il atteint plusieurs kilogrammes en quelques semaines et contraste avec un appétit conservé ou exagéré.

► Les autres signes sont :

- polydipsie
- thermophobie importante alors que la température centrale est à environ 37°5
- accélération du transit intestinal
- troubles neuromusculaires : constants :
 - réflexes osteo-tendineux vifs,
 - le « signe du tabouret » est positif : ce signe permet de rechercher une asthénie musculaire et ce en demandant au patient de s'accroupir ou de s'asseoir sur un tabouret bas : il ne pourra se relever sans appui.

-les troubles psychiques : souvent importants : irritabilité, anxiété, instabilité avec parfois de véritables syndromes dépressifs ou de bouffées d'excitation.

-enfin, il existe souvent :

- des troubles du cycle menstruel : aménorrhée
- des troubles osseux : ostéoporose
- une tendance à l'hyperglycémie fréquente : un diabète sucré avéré est rare

B – Hypothyroïdie

La forme typique est caractérisée par :

1- Une Infiltration cutaneo-muqueuse responsable de la prise de poids du patient

→ **Au niveau cutané** : pâleur cireuse sèche bouffie ayant la consistance d'un faux œdème dur mucoïde doublant les plans cutanés : c'est le myxoœdème

Topographie :

- la face est la plus touchée : front couvert de grosses rides, paupières lourdes rétrécissant la fente palpébrale, joues soufflées erythrosiques, nez épaté, lèvres et oreilles épaissies.

Dans l'ensemble le facies est lunaire, figé, hébété.

- le cou est court et épais
- le thorax massif présente au niveau axillaire des masses de consistance graisseuse
- mains et pieds sont « carrés », les doigts boudinés.

→ **Au niveau muqueux** : on retrouve :

- l'infiltration de la langue : entraînant une macroglossie
- l'infiltration des cordes vocales : entraînant une voix rauque, éteinte
- l'infiltration de la trompe d'eustache : entraînant une hypoacousie

→ **Au niveau des phanères** :

- la dépilation est constante :
 - au niveau des sourcils : signe de « la chute de la queue des sourcils »
 - au niveau axillaire et pubien
- les cheveux sont rares et cassants
- les ongles sont cassants et striés.

2 – Ralentissement psychomoteur :

Il s'agit d'un ralentissement :

- psychique : idéation très ralentie
- physique : les gestes sont lents
- génital : aménorrhée habituelle chez la femme, troubles de la libido.

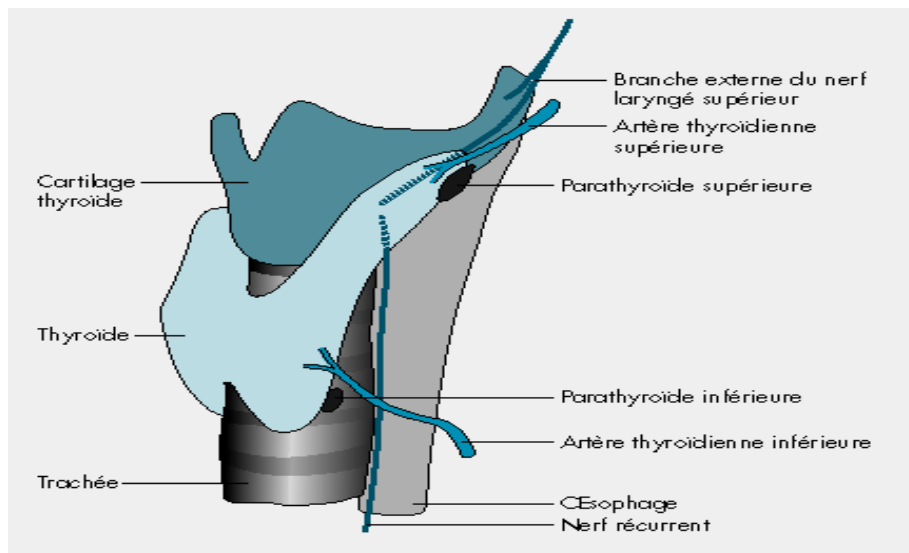
3-Hypothermie : abaissement de la température centrale $< 36^{\circ}5$ d'où la notion de frilosité (patients très habillés toujours couverts même en été par exemple).

4-Troubles cardiaques : bradycardie

5- Troubles neuromusculaires :

- réflexes osteo-tendineux diminués (surtout réflexe achilléen)
- crampes fréquentes et douloureuses

6- Troubles digestifs :



Constipation
souvent opiniâtre.

Figa:Anatomie de la thyroïde et des structures environnantes:vue antérieure ¾

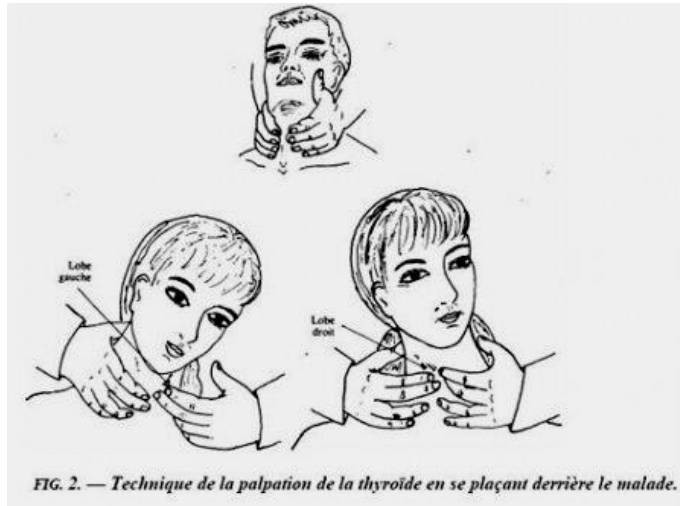
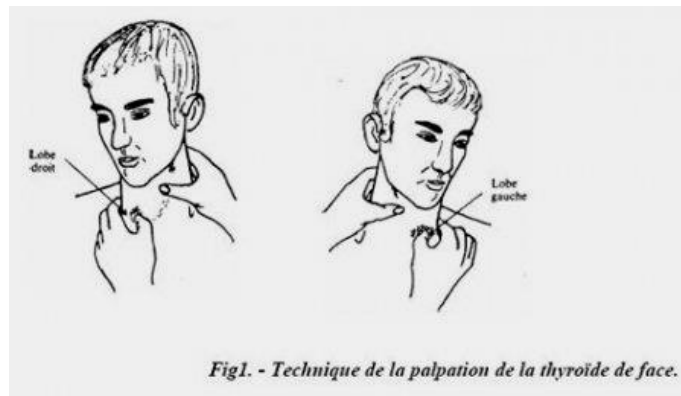


Fig 3.- Maladie de Basedow : Goitre diffus et exophtalmie.

4- Références :

- 1-S. Laboureau-Soares Barbosa, P. Rodien, F. Illouz, V. Rohmer, Hypothyroïdie acquise de l'adulte, EMC Endocrinologie-Nutrition 2009
- 2- F. Borson-Chazot, J. Abeillon-du Payrat, C. Bournaud, Hyperthyroïdie, EMC Endocrinologie-Nutrition 2014
- 3- R.M. Hamladji .Precis de semiologie. 2016

4-Référentiels des Collèges Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques 5^e edition 2021